

# **La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**

## **Informe del Director General**

### **Introducción: un momento crítico para la Salud Mundial**

1. Llegados al ecuador del periodo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no se ha alcanzado ninguno de los 32 indicadores relacionados con la salud que incluyen metas específicas, y de las tendencias actuales se desprende que no se alcanzarán para 2030.<sup>1,2</sup> La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) borró, en un periodo de dos años, un decenio de avances, y la esperanza de vida sana (EVS) pasó de 63,5 años en 2019 a 61,9 años en 2021.
2. En 2021, las diez causas principales de muerte se cobraron 39 millones de vidas, lo que supone el 57 % de los 68 millones de defunciones que se produjeron en todo el mundo. Las enfermedades no transmisibles dominaban la lista, con siete entre las diez causas principales y un 38 % de todas las defunciones. La cardiopatía isquémica siguió siendo la causa principal, responsable del 13 % de todos los fallecimientos. El número de muertes debidas a ella ha aumentado desde el año 2000, y en 2021 alcanzó la abrumadora cifra de 9,0 millones de defunciones.
3. Además de la pandemia, existen otros fenómenos que suponen una amenaza para los avances en la esfera de la salud mundial, a saber, el cambio climático, los conflictos y los cambios en las prioridades de los donantes. Los trastornos que afectan a los sistemas de salud, las limitaciones en materia de recursos y las prioridades contrapuestas podrían ralentizar las iniciativas encaminadas a mejorar la salud y el bienestar. Es fundamental robustecer la adopción de decisiones basada en datos, dotarse de unos sistemas de salud resilientes y mejorar la preparación frente a emergencias.
4. La OMS hace un seguimiento de las tendencias en materia de salud, proporciona orientaciones técnicas y presta apoyo a los países para establecer unos sistemas de salud sólidos. En 2016, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA69.11, que integraba la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y exigía que, cada dos años, se presentara información

---

<sup>1</sup> [World Health Statistics 2024](#). Geneva: World Health Organization; 2024 (consultado el 12 de marzo de 2025).

<sup>2</sup> De los 57 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de salud y relacionados con la salud, 32 incluyen metas cuantitativas específicas que deben alcanzarse para 2030.

actualizada sobre los progresos realizados. Si bien la responsabilidad de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible recae en los Estados Miembros, la OMS desempeña un papel clave en la tarea de acelerar los avances y monitorear los resultados de salud. El 13.º Programa General de Trabajo 2019-2025 estaba alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y proporcionaba un marco para medir los avances a través de la EVS, las metas de los tres mil millones y 46 indicadores de efectos (39 de los cuales son indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

5. En este quinto informe de la serie se examinan los progresos realizados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, articulados en torno a las tres prioridades (metas de los tres mil millones): promover, procurar y proteger la salud. En él se destacan los desafíos principales, el papel de los sistemas de datos sanitarios y los esfuerzos de la OMS para impulsar la acción.<sup>3</sup> En la última sección se presenta el 14.º Programa General de Trabajo 2025-2028, que establece nuevos objetivos para acelerar los avances.

## **Progresos en cuanto a la consecución de las metas de los tres mil millones y los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud**

### **Promover la salud**

6. **Mejor salud para mil millones más de personas:** según las previsiones, 1400 millones de personas más disfrutaron de una mejor salud en 2024 con respecto a la cifra de 2018, principalmente debido a las mejoras en la calidad del aire y en materia de agua, saneamiento e higiene (ASH). Con todo, estos avances son insuficientes para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

7. Se estima que, en 2019, 1,4 millones de personas murieron debido a la exposición a unos servicios de agua, saneamiento e higiene insalubres, mientras que 6,7 millones de defunciones estuvieron vinculadas a los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente procedente de la materia particulada.

8. El retraso del crecimiento infantil pasó del 26,4 % (2012) al 23,2 % (2024), la emaciación disminuyó ligeramente (del 7,4 % al 6,6 %) y el sobrepeso aumentó ligeramente (del 5,3 % al 5,5 %).

9. El consumo de tabaco bajó, del 23,9 % en 2015 al 20,9 % en 2022, mientras que el consumo per cápita de alcohol disminuyó y pasó de 5,9 litros en 2015 a 5,0 litros de alcohol puro en 2022. En 2021 se produjeron 15,0 muertes por cada 100 000 personas en accidentes de tránsito.

### **Procurar salud**

10. **Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas:** El mundo no alcanzó la meta de la cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas para 2024 y se quedó en 431 millones de personas. Aproximadamente 4500 millones de personas siguen sin tener acceso a servicios de salud esenciales. En 2019, cerca de 2000 millones de personas tuvieron que hacer frente a dificultades financieras como consecuencia de los costos de la atención de la salud, incluidos 344 millones de personas en situación de pobreza extrema. A pesar del déficit mundial

---

<sup>3</sup> Las fuentes de datos que se emplean en el presente documento incluyen la [Base de Datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas](#) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, las [Estimaciones Mundiales de Salud de la OMS correspondientes a 2021](#) y el [Observatorio Mundial de la Salud de la OMS](#) (consultado el 12 de marzo de 2025).

general, el 30 % de los países han realizado avances tanto a la hora de ampliar la cobertura de los servicios como de mejorar la protección financiera.

11. La cobertura universal de los servicios de salud mejoró, pasando de 65 en 2015 a 68 en 2021; no obstante, la proporción de personas que se enfrentan a dificultades financieras como consecuencia de unos gastos directos en atención de salud superiores al 10 % del presupuesto del hogar aumentó, pasando del 12,6 % en 2015 al 13,5 % en 2019, lo que pone de relieve que persisten los obstáculos para una atención de la salud asequible.

12. La razón de mortalidad materna continúa siendo elevada, si bien se redujo y pasó de 220 por cada 100 000 nacidos vivos en 2016 a 197 en 2023. Al ritmo actual, en 2030 la razón de mortalidad materna a escala mundial seguirá multiplicando por 2,5 la meta mundial fijada para 2030, que era de 70.

13. La tasa de mortalidad de los menores de 5 años disminuyó, de 44 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos en 2015 a 37 en 2023, mientras que la mortalidad entre los niños recién nacidos pasó de 20 muertes por cada 1000 nacidos vivos a 17. Con todo, los avances siguen siendo demasiado lentos para alcanzar las metas de 2030, a saber, no más de 12 defunciones por cada 1000 recién nacidos y, en el de los menores de 5 años, 25 por cada 1000, de modo que es preciso acelerar la adopción de medidas.

14. La cobertura de inmunización de la tercera dosis contra la difteria, la anatoxina tetánica y la tos ferina entre los niños de un año disminuyó ligeramente en todo el mundo, y pasó del 85 % en 2015 al 84 % en 2023. El número de niños que no han recibido ninguna dosis contra la difteria, la anatoxina tetánica y la tos ferina aumentó en todo el mundo: de 12,8 millones en 2019 a 14,5 millones en 2023. Sin embargo, la cobertura de la segunda dosis de la vacuna antisarampionosa y de la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada aumentó entre 2015 y 2023 en un 11 % y un 27 %, respectivamente.

15. En 2023, se estima que 1,3 millones de personas se infectaron por el VIH, una cifra inferior a los 1,8 millones de nuevas infecciones en 2015. No obstante, el número de personas que enfermaron de tuberculosis aumentó, de 10,1 millones en 2020 a 10,8 millones en 2023, lo que revirtió años de disminución constante. La tasa de incidencia del paludismo aumentó, de 58,0 casos por cada 1000 habitantes en situación de riesgo en 2015 a 60,4 casos por cada 1000 habitantes en situación de riesgo en 2023. El número de personas que requirieron intervenciones por enfermedades tropicales desatendidas pasó de 1800 millones en 2015 a 1500 millones en 2023, lo que demuestra que los esfuerzos en materia de control de enfermedades han dado resultados.

16. Antes de la pandemia de COVID-19, una persona de 30 años tenía, en 2019, un riesgo del 18,0 % de morir de una de las cuatro principales enfermedades no transmisibles antes de los 70 años. Sin embargo, desde 2015, el descenso en la mortalidad debida a enfermedades no transmisibles se ha ralentizado, lo que indica que es urgente dotarse de unas políticas de prevención más sólidas y de programas de detección precoz, así como mejorar el acceso a los servicios de atención de la salud esenciales. La expansión del control del tabaco, unas dietas más saludables, la promoción de la actividad física y un mejor manejo de la hipertensión arterial y de la diabetes serán fundamentales para revertir esta tendencia.

17. Se han estancado los avances hacia el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. La proporción de mujeres de 15 a 49 años con necesidades de planificación familiar satisfechas mediante métodos modernos aumentó en poco

menos de un 1 %, pasando del 76,5 % en 2015 al 77,1 % en 2024, lo que pone de relieve la necesidad urgente de ampliar el acceso y los servicios.

18. En cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, la prevalencia mediana de los casos de septicemia causada por el *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina entre los pacientes que buscan atención pasó del 13,4 % en 2016 al 32,2 % en 2022. Los casos de septicemia causada por la *Escherichia coli* resistente a las cefalosporinas de tercera generación también aumentaron del 26,9 % en 2016 al 45,5 % en 2022. Este incremento obedece también al aumento progresivo de los datos recogidos en lugares con recursos limitados.

## Proteger la salud

19. **Protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas:** Según las previsiones, unos 637 millones de personas más estuvieron mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias en 2024 en comparación con la cifra de 2018.

20. El fortalecimiento de las capacidades básicas requeridas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) contribuyó a mejorar la preparación frente a emergencias en 2022-2023. Sin embargo, la cobertura de inmunización para patógenos de alta prioridad aún no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia. La segunda edición del instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados Partes (instrumento SPAR) en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) amplió de 13 a 15 capacidades la medición de la preparación nacional frente a emergencias sanitarias. Con todo, entre 2021 y 2023, la puntuación media mundial del instrumento SPAR no sufrió cambios y siguió siendo de 64. De las 15 capacidades, 6 disminuyeron, mientras que en otras 6 no hubo cambios, lo que pone de relieve la necesidad de mayores inversiones y de intervenciones específicas encaminadas a mejorar la preparación. Las puntuaciones relativas a la gestión de las emergencias sanitarias se estancaron en 70 entre 2021 y 2023, lo que indica que se requerían mayores inversiones en sistemas de respuesta.

## Fortalecimiento de los datos y los sistemas de información sanitaria

21. Durante el 13.º Programa General de Trabajo 2019-2025, no fue posible alcanzar dos de las tres «metas de los tres mil millones». Acelerar el progreso y lograr resultados en los países implica implementar enfoques de prestación basados en datos. Promover unas plataformas integradas, aplicar soluciones de salud digital e innovaciones que puedan ampliarse, incentivar las alianzas y la colaboración multisectorial y obtener financiación innovadora para la salud pública serán elementos esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

22. De conformidad con lo solicitado por los Estados Miembros, la Secretaría está trabajando con los ministerios de salud, los ministerios de información y tecnología, las oficinas nacionales de estadística y las oficinas del registro civil para mejorar la vigilancia de la salud pública, el registro civil y las estadísticas vitales, los sistemas de información sanitaria ordinarios y la salud digital.

23. La OMS ha establecido distintas plataformas fundamentales, como el Centro Mundial de Datos de Salud, el Centro de Información de la OMS sobre Pandemias y Epidemias, la Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025 y el Centro de Sistemas de Información Geográfica para la Salud, así como Investigación para la Salud, a fin de facilitar el acceso y el uso de los datos sanitarios y dotar a los expertos en salud pública y a los responsables de la formulación de políticas de todo el mundo de las herramientas necesarias para predecir, detectar y evaluar los riesgos epidémicos y pandémicos. Estas herramientas permiten una toma rápida de decisiones

para prevenir y responder a futuras emergencias de salud pública, y mejoran la pertinencia de los datos para las hipótesis en tiempo real, reforzando así las capacidades predictivas.

24. La OMS está intensificando su apoyo técnico y operacional a los Estados Miembros para la planificación de sistemas de salud digital sólidos y resilientes y la implementación de tecnologías, normas abiertas y contenidos de calidad garantizada adaptados al contexto que apoyen las prioridades y estrategias nacionales de salud con arreglo a los principios de inclusión y equidad. Ello se complementará con el apoyo a la aplicación de herramientas digitales de referencia, sistemas de información, elementos constitutivos y estrategias, proyectos y políticas que ayuden a los gobiernos a promover la transformación hacia la salud digital.

25. Los datos desglosados y el monitoreo de la desigualdad son cruciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que revelan las disparidades en el seno de las poblaciones, lo que permite llevar a cabo intervenciones específicas y formular políticas informadas. La OMS está ampliando su apoyo técnico a fin de que los países puedan determinar las subpoblaciones que se están quedando atrás y ayudar a garantizar que los progresos sean inclusivos y equitativos.

26. Continuamente, se introducen mejoras en los informes estadísticos y las herramientas clave a fin de reflejar de manera precisa los cambios constantes en el panorama mundial de salud. Entre los ejemplos más destacados cabe destacar el Informe sobre Estadísticas de Salud Mundial, las Estimaciones Mundiales de Salud y el Informe de Monitoreo Mundial de la CSU. La OMS está fomentando la colaboración con miras a ampliar la implementación de soluciones digitales interoperables, como la 11.ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades en los países.

## **De cara al futuro: 14.º Programa General de Trabajo 2025-2028**

27. El 14.º Programa General de Trabajo 2025-2028, que se basa en las enseñanzas extraídas del 13.º Programa General de Trabajo 2019-2025 y de la pandemia de COVID-19, hace del impacto mensurable en los países el eje de la estrategia de la Organización, y promueve las declaraciones políticas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.<sup>4</sup>

28. El marco de resultados del 14.º Programa General de Trabajo se estructura alrededor de dos componentes: una cadena de resultados general —desde los insumos hasta el impacto— y un sistema específico de medición de los resultados.

29. Se han recalibrado las metas de los tres mil millones para el 14.º Programa General de Trabajo 2025-2028 a fin de tener en cuenta los cambios en el contexto de salud y las mejoras en la medición del impacto. Ahora reflejan las referencias absolutas de cobertura poblacional para 2028. Las metas recalibradas son:

- que 6000 millones de personas disfruten de mejor salud y bienestar;
- que 5000 millones de personas gocen de cobertura sanitaria universal sin sufrir dificultades económicas;
- que 7000 millones de personas estén mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias.

---

<sup>4</sup> Véase el documento A77/16.

30. Tomados conjuntamente, los esfuerzos de los Estados Miembros, los asociados y la Secretaría se evaluarán utilizando unos indicadores de efectos específicos y los índices compuestos de la OMS para las metas de los tres mil millones, mientras que el impacto continuará midiéndose a través de parámetros clave como la exposición al riesgo, la cobertura de los servicios, la morbilidad y la mortalidad y la EVS.

31. En vista de unas necesidades que aumentan más rápidamente que los recursos para atenderlas, a fin de maximizar el impacto es necesario centrarse en los planos nacional, regional y mundial. El marco de resultados del 14.º Programa General de Trabajo propone aumentar el monitoreo en tiempo real de los progresos realizados y la rendición de cuentas al respecto. Sobre la base de la búsqueda del máximo impacto que las inversiones pueden tener en la salud, será importante centrarse en las esferas prioritarias a fin de prestar apoyo a los países y a los asociados con miras a prevenir las muertes prematuras y mejorar la calidad de vida en todas las edades, ahorrando al mismo tiempo decenas de miles de millones de dólares mediante la reducción de los costos en materia de salud y un aumento de la productividad.

## **Intervención de la Asamblea de la Salud**

32. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del presente informe y facilite orientaciones sobre las preguntas siguientes:

- A la luz de los avances insuficientes en cuanto a la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud, ¿qué pueden hacer los países que están avanzando a un ritmo más lento para traducir el compromiso político en acciones tangibles, por ejemplo, movilizando recursos, fortaleciendo la rendición de cuentas y utilizando estrategias impulsadas por los datos para acelerar los progresos a nivel nacional y subnacional?
- En el contexto de las limitaciones financieras en materia de salud mundial, ¿de qué manera pueden la OMS y sus asociados apoyar a los Estados Miembros en la tarea de establecer prioridades y fortalecer la asistencia técnica a fin de dirigir los recursos hacia unos resultados sostenidos, con los que los países se identifiquen y que estén orientados a los resultados que aceleren los avances hacia las metas relacionadas con la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de los tres mil millones?
- ¿Cómo pueden priorizar los países y la OMS unos sistemas sólidos de datos e información sanitaria, e invertir en ellos, como base para disponer de unos sistemas de salud más sólidos, una mejor vigilancia de la salud pública y una acción más rápida y eficaz, garantizando al mismo tiempo la oportunidad, la exactitud y la accesibilidad de los datos?

---